

Parésie

Anamnèse

1. Caractériser

a. Condition de survenue ?

- i. Brutal ?
- ii. Traumatisme ?
- iii. Depuis quand ?
- iv. Évolution ?

b. Signes associés ?

- i. Trouble de la parole ?
- ii. Trouble de la vue ?
- iii. Trouble de l'audition ?
- iv. Vertiges ?**
- v. Céphalées intenses ?**

c. Localisation

- i. Membre touché ? Quel mouvement ?

d. Facteurs aggravants/soulageant

e. Matin mieux que le soir ?

2. Symptômes associés

a. Douleur

- i. Localisation
- ii. Irradiation
- iii. Qualité
 - 1. Brûlures**
 - 2. Décharge électrique**
- iv. Intensité
- v. Chronologie
- vi. Facteurs aggravants / soulageant
 - 1. Effort
 - 2. Toux

b. Paresthésie (fourmillement) (+ localisation et autre caractérisation)

c. Hypoesthésie (+ localisation et autre caractérisation)

d. Atrophie

e. Autre ?

3. Marche

- a. Symptômes apparaissent après distance fixe ?
- b. Toujours présent

4. Système digestif

a. **Selles** → faire TR

- i. Incontinence, fuites
- ii. Constipation

b. Urines

- i. Incontinence, fuites
- ii. Vidange incomplète

AVC URGENCE

- **Paralysie du visage**
- **Paralysie du bras ou jambe**
- **Trouble de la parole**
- **Trouble de la vue**
- **Vertiges violents**
- **Maux de tête intense**

5. ATCD personnels
 - a. Symptômes similaires par le passé
 - b. Maladie
 - c. Hospitalisation
 - d. Opération
 - e. Médicaments
 - f. Allergie
6. ATCD familiaux
7. Habitudes
 - a. Tabac
 - b. Alcool
 - c. Drogue

DD

- **AVC/AIT**
- **Trauma moelle**
 - o **Totale**
 - o **Hémi-moelle** (hémiparésie + dissociation entre côté atteint proprioception et sensibilité douleur/chaleur)
 - o **Antérieur** (hémiparésie + abolition thermoalgésie alors que tactile ok)
- **Myélopathie** (démarche ataxique, perte motricité fine, parésie, hyperréflexe, signes pyramidaux : Babinski +)
 - o *Mécanique : canal étroit, hernie, processus expansif, hématome, traumatisme, abcès épidural)*
 - o *Métabolique : myélose funiculaire (déficit B12)*
 - o *Infectieux : polio, coxsackie, herpès, EBC, CMV, HIV, syphilis, lyme, maladie de Pott*
 - o *Inflammatoire : SEP, lupus, Sjögren*
 - o *Vasculaire : ischémique (début subaigu)*
 - o *Paranéoplasique : cancer pulmonaire, lymphome, ...*
- **Syndrome radiculaire**
 - o *Irritatif* (Douleur neuropathie intense unilatérale (dermatome), paresthésie, majoré par l'effort, la toux + reproductible par l'étirement)
 - o *Déficitaire* (hypoesthésie, parésie (myotome) + abolition réflexe, atrophie)
- **Polyneuropathie** (= purement sensitif au début, distal, bilatérale, symétrie, synchrone, pts diabétique)
- **Polyradiculoneuropathie chronique** (prédominance motrice, atteinte sensitive surtout proprioception → trouble de la marche, instabilité, non longueur dépendant, +/- symétrique)
- **Polyradiculoneuropathie aiguë : Guillain-Barré** (prédominance motrice, atteinte sensitive surtout proprioception → trouble de la marche, instabilité, non longueur dépendant, +/- symétrique + précédé d'un **épisode infectieux respiratoire ou digestif**, ! on ne fait qu'un Guillain-Barré dans sa vie)
- **Myasthénie** (ptosis, paralysie faciale, dysphagie, faiblesse nuque, difficulté de tenir les bras tendus et les jambes fléchies, mieux le matin que le soir, dépend de la fatigue)
- **Sclérose latérale amyotrophique** (uniquement motrice, faiblesse, amyotrophie, fasciculations,, crampes → atteinte du 1^{er} et du 2^{ème} motoneurone)

Examen clinique

Faire examen neuro normal

1. **Orientation**

- a. **Comment vous-vous appelez ?**
- b. **Où êtes-vous ?**
- c. **Quelles dates sommes-nous ?**

2. **Cincinatti pour suspicion AVC :**

- a. Motricité de la face NII
- b. Épreuve des bras tendus
- c. Répétition d'une phrase

3. Marche

- a. Normal
- b. Pointe / talon +/- funambule

4. Romberg (main tendue d'abord yeux ouverts ensuite avec fermés)

5. **Nerfs crâniens**

6. Inspection - palpation muscle → amyotrophie ?

7. Membre sup force contre résistance

- a. Épreuve bras tendu (DDC)
- b. Abduction latérale (DDC)
- c. Rotation latérale épaule (DDC)
- d. Flexion avant-bras
- e. Extension bras
- f. Flexion poignet
- g. Extension poignet
- h. Abduction des doigts (ouvrir doigt contre pression)
- i. Flexion des doigts (doigt en crochet)
- j. Extension des doigts (paume vers le bas)

8. Réflexe (!!! comparer des 2 côtés)

- a. Tricipital (C7)
- b. Bicipital (C6)
- c. Stylo-radial (C6)
- d. Rotulien (L3-L4)
- e. Achilléen (S1)

9. Membre inf force contre résistance

- a. Épreuve jambes fléchies
- b. Flexion hanche
- c. Extension hanche (main sous pied)
- d. Flexion genou
- e. Extension genou
- f. Flexion pied (tirer patient en bas de la table)
- g. Extension pied
- h. Flexion gros orteil
- i. Extension gros orteil

10. Babinski

!!! si symptômes
seulement MI depuis dos
→ faire examen du rachis +
neuro membre inf +
lasègue et lasègue inversé

11. Sensibilité

- a. **Tact global**
- b. Piqûre global
- c. Toucher – piquer
- d. Position doigt – orteil
- e. Pallesthésie poignet / cheville

!!! faire toucher piquer, sensibilité profonde (position doigt), pallesthésie etc seulement si plainte de la sensibilité globale ou de la sensibilité à l'anamnèse